

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011213-69.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCOS PAULO EZEQUIEL AFFONSO

RECORRIDO: VALERIA CONCEICAO DE OLIVEIRA AFFONSO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSULTA ONCOLÓGICA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5011213-69.2025.4.02.5101

510015673377 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011213-69.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCOS PAULO EZEQUIEL AFFONSO

RECORRIDO: VALERIA CONCEICAO DE OLIVEIRA AFFONSO

RELATÓRIO

Trata-se de medida recursal interposta pela União Federal em face da decisão de evento 10, DESPADEC1 dos autos originários que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus providenciem ao autor a imediata consulta - ambulatório 1ª vez - COLOPROCTOLOGIA (oncologia), com o subsequente tratamento oncológico adequado.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; violação ao princípio da isonomia; impossibilidade de custeio de procedimentos em unidade privada de saúde; além do necessário direcionamento ao ente federativo administrativamente competente.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão inicial indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Em juízo perfunctório, verifica-se a presença dos requisitos supracitados, haja vista que os documentos dos autos originários comprovam que o recorrido recebeu diagnóstico de **neoplasia maligna do reto**, encontrando-se em fila para atendimento oncológico desde **02/09/2024** (evento 31, PARECER1).

Ou seja, em muito já se passou o prazo legal para que o autor desse início ao tratamento oncológico que comprovadamente necessita, pois a Lei nº 12.732/2012, que dispõe sobre o tratamento de paciente com neoplasia maligna, estabelece o prazo 60 (sessenta) dias contado do dia em que foi firmado o primeiro diagnóstico:

Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta **Lei**.

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

Por esses fundamentos, não se mostra razoável que o autor aguarde em fila de espera ou por um provimento jurisdicional em cognição exauriente, não havendo o que se falar em violação ao princípio da isonomia, já que os pacientes oncológicos possuem o privilégio legal de serem atendidos com máxima celeridade diante da própria natureza da doença acometida.

Ademais, a competência para a tutela do direito fundamental à saúde é solidária entre todos os entes federados, conforme entendimento pacífico do Pretório Excelso, de modo que eventuais atos infralegais que estabeleçam atribuições administrativas distintas aos referidos entes não podem se sobrepor ao entendimento do STF, nem ao que dispõe a Carta Magna.

Por fim, embora a decisão a quo não tenha mencionado, em caso de ausência de vagas na rede pública é plenamente possível que a consulta e o início do tratamento ocorram na rede privada em convênio com o SUS, direito esse já reconhecido pelo STJ, veja-se:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. (...) 5. **A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.** 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1803426 RN 2019/0081442-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 30/05/2019).

Portanto, o recurso interposto pela União possui natureza meramente protelatória, uma vez que estão claramente presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme acima explanado, além da inequívoca mora do Poder Público, devendo ser mantida integralmente a decisão a quo.

Ante o exposto, **INDEFIRO** a atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida, mantendo-a por seus próprios fundamentos."

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da existência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* que motivaram a concessão antecipação de tutela na origem, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

